

MARCO ANTONIO PINTO				
MEDICAMENTOS:				
SINTOMAS/QUEIXAS				
BANHEIRO				
HORA QUE ACORDA				
HORA QUE DORME				
PRATICA EXERCICIO				
HORARIO DAS REFEIÇÕES				
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:	
00/06/22	P = 6.6 aumentado p/ 7.0 IAH = 2.5. m. de uso: 6hr Oriento a higiene			fua
20/06/22	P = 7 cmH ₂ O IAH = 2.7. m. de uso: 6h24'	↓ 6.4 cmH ₂ O		fua cláudio
20/07/22	P = 6.4 cmH ₂ O. IAH = 2.0 m. de uso: 6hr.			fua
28/09/22	P = 6.4 cmH ₂ O IAH = 1.9/lv m. de uso: 6hr Bem adaptado, 11 queixas			fua
29/11/22	P = 6.4 cmH ₂ O IAH = 1.8 e/lv m. de uso: 6h20' Bem adaptado, relata melhora gló lomaço			fua.
31/01/23	P = 6.4 cmH ₂ O IAH = 1.7 e/lv m. de uso: 6h20' Fuga: 10.2	- Bem adaptado. - fazer Biologia		fua
12/04/2023	P = 6.4 cmH ₂ O IAH = 1.6 e/lv m. de uso = 6h23' fuga = 6l/min	• tocou prong por conta própria Bem adaptado		
13/06/23	P = 6.4 cmH ₂ O IAH = 0.9 e/lv m. de uso: 6hr.	Bem adaptado		fua.

17/08
23

P = 6.4 cmH₂O
IAH = 1.3 e/ev
m. de uso: 6h10'

Bem adaptado, relata obstr. nasal → maxilibrat - f

P = 6.4 cmH₂O

Fuga = 18.1

IAH = 2.5 e/ev
m. de uso: 6h
Bem adaptado.

Bem adapt.

fua

20/03/24

P = 6.4 cmH₂O
IAH = 2.8 e/h
m. de uso: 5h55'
Bem adaptada

Natasha

07/06
24

P = 6.4 cmH₂O
IAH = 3.4 e/ev
m. de uso: 6h15'
Fuga = 6h15'

fua cláudio

28/08
24

P = 6.4 cmH₂O
IAH = 2.4 e/ev
Fuga = 6h45'

fua

27/11/24

P = 6.4 cmH₂O
IAH = 3.8 e/h
m. de uso: 6 horas
fuga = 13el min

silvz

~~fua~~

28/02/25

P = 6.4 cmH₂O
IAH = 2.8 e/h
m. de uso: 6h04 min
fuga = 23el min

Bem Adaptado.

sono reparado

silvz

fua

28/05
25

P = 6.4 cmH₂O
IAH = 2.8 e/ev
m. de uso: 6h5'
fuga = 17.2 e/ev

fua cláudio

clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
FISICOTERAPIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificado em Medicina do Sono
Sociedade Brasileira de Sono
Membro da Associação Brasileira de
Doutor em Ciências pela UNESP
CRM-SP: 69.730

Dra. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Kronograma de Atendimento
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Marco Antonio Pinto

EXAME nº: 4990

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 22/10/2021

IDADE: 59 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h15min e concluído às 05h36min. A latência para o sono foi de 7 minutos e a latência para o estágio REM, de 75 minutos. O tempo total de sono foi de 351 minutos (05h51min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 79,4%. A distribuição do sono registrado mostrou 16% de estágio 1, 46,2% de estágio 2, 17% de estágio 3 e 20,9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 84 minutos em vigília, ocorreram 142 microdespertares (índice: 24,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 33/hora, sendo 2,6 apneia/hora e 30,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 33/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a média de 93% e a mínima de 79%.

(*) TTS⇒ Tempo Total de Sono

TTR⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (33/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (33/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, ritmo cardíaco sinusal e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 69 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 7 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (75 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 79,4%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 24,3/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (16%; normal: 8-10%), 3 (17%; normal: 10-12%) e REM (20,9%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (46,2%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros. Observei movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 21 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Especialista em Medicina do Sono
Especialista em Distúrbios do Sono
Médico Responsável pelo Laboratório
CRM-SP: 69730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTE
Téc. em Polissonografia
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Marco Antonio Pinto

EXAME nº: 4990-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Flávio Augusto Passarelli Prado

DATA: 13/04/2022

IDADE: 59 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h44min e concluído às 05h37min. A latência para o sono foi de 4 minutos e a latência para o estágio REM, de 61 minutos. O tempo total de sono foi de 366 minutos (06h06min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 88,4%. A distribuição do sono registrado mostrou 11,7% de estágio 1, 51,8% de estágio 2, 15,8% de estágio 3 e 20,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 43,5 minutos em vigília, ocorreram 149 microdespertares (índice: 24,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 2,1/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 15,2/hora, sendo 0,2 apneia/hora e 15,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 15,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a média de 94% e a mínima de 85%.

(*) TTS → Tempo Total de Sono

TTR → Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação para o aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6,5 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (15,2/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (15,2/hora), despertares, arritmia cardíaca (extrassístoles) e episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. As frequências cardíacas foram: mínima: 56; máxima: 73 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 4 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (61 min; normal: 70 a 120 min).

Apesar da eficiência do sono normal (88,4%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 24,4/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,7%; normal: 8-10%) e 3 (15,8%; normal: 10-12%). As porcentagens dos estágios 2 (51,8%; normal: 45-55%) e REM (20,6%; normal: 20%) permaneceram nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (2,1/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730